



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
UNIT DRIVER AMBULANCE
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 239.2/I-PDM/DIR/IV/2026

Tentang
PEDOMAN PELAYANAN UNIT DRIVER AMBULANCE

Disusun Oleh :
Kepala Bagian Umum



drg. Endy Wira Pradana.,M.MRS

Disetujui Oleh :
Authorized Person



Dr. Dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini.,M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat tuhan yang maha esa karena atas rahmatnya pedoman layanan Unit Driver Ambulance dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Pelayanan unit driver Ambulance ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2026 dengan melalui berbagai review dan update dari beberapa literatur. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan unit driver Ambulance ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit prima husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini.,M.Kes

TIM PENYUSUN

1. dr. Resti Lestantini.,M.Kes
2. Drg. Endy Wira Pradana.,M.MRS
3. M. Ridzal S.E
4. Edi Nur Slamet
5. Agus Suhartono
6. Eriawan
7. Guruh Hadi Wardono
8. M. Arif

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
TIM PENYUSUN	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Ruang Lingkup Pelayanan	10
1.3. Batasan Operasional	11
BAB II STANDAR KETENAGAAN	12
2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia	12
2.2. Distribusi Ketenagaan	12
2.3. Pengaturan Jaga/Dinas	12
BAB III STANDAR FASILITAS	13
3.1. Denah Ruangan	13
3.2. Standard Fasilitas	13
BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN	15
BAB V TATA LAKSANA	17
5.1 Tata Laksana Transportasi Pasien	17
5.1.1 Sistem Transportasi Pengantaran Pasien Pulang	17
5.1.2 Sistem Transportasi Rujukan	17
5.1.3. Sistem Transportasi Home Care	18
5.1.4 Sistem Transportasi Ambulance On Call	18
5.1.5 Sistem Transportasi Pengantaran Jenasah	19
5.2 Tata Laksana Pembersihan Armada	19
BAB VI LOGISTIK	20
6.1 Administrasi Dan Pengelolaan	22
6.2. Penyediaan Peralatan Dan Obat-Obatan	22
6.3. Pemeliharaan Dan Penyediaan Bahan Bakar	23
BAB VII KESELAMATAN PASIEN	24
7.1 Ruang Lingkup	24
7.2 Tujuan	24
7.3 Standar Keselamatan Pasien	24
7.4 Pelaksanaan	24
7.5 Pengendalian Infeksi	25
7.6 Mengurangi Resiko Pasien / Jenasah Jatuh	25
BAB VIII KESELAMATAN KERJA	27
8.1 Pelatihan Rutin	27
8.2. Penggunaan Alat Pelindung	27
8.3. Prosedur Tanggap Darurat	27
BAB IX PENGENDALIAN MUTU	28
BAB X PENUTUP	29



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 239.2/I-PDM/DIR/IV/2026

TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN UNIT DRIVER AMBULANCE

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu menjamin pelayanan transportasi pasien yang aman, cepat, dan sesuai standar di Rumah Sakit;
- b. Bahwa agar pelayanan driver Ambulance dan transportasi pasien dapat terlaksana secara profesional, aman, dan terintegrasi, perlu adanya Pedoman Pelayanan Unit Driver Ambulance;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan direktur tentang Pedoman Pelayanan Unit Driver Ambulance;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 233.10/DPM/I-KEP/DIR/IV/2026 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT DRIVER AMBULANCE

BAB I

PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN KESELAMATAN

Pasal 1

1. Unit Driver Ambulance dibentuk untuk mendukung pelayanan transportasi pasien yang aman, cepat, dan sesuai standar medis, baik dalam kondisi darurat maupun non darurat.
2. Unit Driver Ambulance bertanggung jawab dalam pengoperasian kendaraan Ambulance serta mendukung kegiatan pelayanan medis dan operasional rumah sakit.
3. Segala kegiatan operasional dan rapat Unit Driver Ambulance diatur oleh Koordinator Driver Ambulance, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
4. Unit Driver Ambulance menjalin koordinasi dengan unit IGD, rawat inap, rawat jalan, serta unit terkait lainnya.
5. Rapat rutin Unit Driver Ambulance dilaksanakan minimal satu bulan sekali atau sesuai kebutuhan operasional.

BAB II

ORGANISASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 2

Rumah sakit menetapkan sistem koordinasi antara pimpinan rumah sakit dan Unit Driver Ambulance dalam pelaksanaan pelayanan transportasi pasien yang meliputi:

1. Penetapan standar pelayanan transportasi pasien;
2. Pengelolaan risiko keselamatan pasien selama transportasi;
3. Sistem komunikasi dan respon cepat pelayanan Ambulance;
4. Mekanisme pelaporan kejadian dan insiden transportasi pasien.

Pasal 3

- (1) Rumah sakit menetapkan Koordinator Driver Ambulance.
- (2) Jumlah personel driver disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- (3) Kualifikasi driver meliputi:
 1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat;



2. Memiliki SIM sesuai kendaraan;
3. Telah mengikuti pelatihan Basic Life Support (BLS) atau pelatihan kegawatdaruratan;
4. Memahami keselamatan pasien dan PPI;
5. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik

Pasal 4

Rumah sakit menempatkan driver Ambulance pada area pelayanan yang membutuhkan dukungan transportasi pasien secara cepat dan tepat, terutama pada unit berisiko tinggi seperti IGD.

BAB III

KEGIATAN DAN TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 5

Pelayanan Unit Driver Ambulance meliputi:

1. Pengantaran pasien rujukan ke fasilitas kesehatan lain;
2. Penjemputan pasien dari lokasi kejadian atau fasilitas kesehatan lain;
3. Transportasi pasien dalam kondisi darurat dan non darurat;
4. Pengantaran jenazah;
5. Dukungan kegiatan medis dan operasional rumah sakit.

Pasal 6

Unit Driver Ambulance melaksanakan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Setiap pelayanan wajib memperhatikan:

1. Keselamatan pasien;
2. Keselamatan petugas;
3. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI);
4. Kesiapan kendaraan dan peralatan medis.
5. Dilakukan pemeriksaan rutin kendaraan (checklist harian, mingguan, dan berkala).
6. Driver wajib menjaga kebersihan, kelayakan, dan kesiapan Ambulance setiap saat.
7. Dalam kondisi darurat, driver wajib merespon dengan cepat sesuai sistem respon time rumah sakit

BAB IV



PENUTUP

Pasal 7

1. Unit Driver Ambulance wajib melakukan pencatatan setiap kegiatan pelayanan.
2. Setiap kejadian insiden keselamatan pasien atau kecelakaan wajib dilaporkan sesuai sistem pelaporan rumah sakit.
3. Laporan kegiatan disampaikan secara berkala kepada pimpinan rumah sakit.

Pasal 8

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Malang
Pada Tanggal 18 April 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini.,M.Kes



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR 239.2/I-

PDM/DIR/IV/2026 TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN UNIT

DRIVER AMBULANCE.

PEDOMAN PELAYANAN UNIT AMBULANCE TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan Transportasi Pasien Merupakan Bagian Penting Dalam Sistem Pelayanan Rumah Sakit Yang Berhubungan Langsung Dengan Keselamatan Pasien. Driver Ambulance Memiliki Peran Strategis Dalam Memastikan Pasien Dapat Dipindahkan Dengan Aman, Cepat, Dan Tepat Sesuai Kondisi Medisnya. Oleh Karena Itu Diperlukan Pedoman Pelayanan Yang Jelas Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Tugas.

1.2. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan Unit Driver Ambulance Mencakup Seluruh Aktivitas Transportasi Pasien Di Lingkungan Rumah Sakit, Meliputi:

1. Pengantaran Pasien Rujukan

Pelayanan Pengantaran Pasien Rujukan Adalah Kegiatan Memindahkan Pasien Dari Rumah Sakit Prima Husada Ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang Memiliki Kemampuan Lebih Tinggi Atau Fasilitas Yang Lebih Lengkap Sesuai Dengan Kebutuhan Medis Pasien. Dalam Pelaksanaannya, Driver Ambulance Memastikan Perjalanan Berlangsung Aman, Cepat, Dan Stabil, Serta Berkoordinasi Dengan Tenaga Medis Terkait Kondisi Pasien Selama Proses Rujukan Berlangsung.

2. Penjemputan Pasien

Penjemputan Pasien Merupakan Pelayanan Mengambil Pasien Dari Lokasi Tertentu, Seperti Rumah Pasien Atau Fasilitas Kesehatan Lain, Untuk Dibawa Ke Rumah Sakit Guna Mendapatkan Pelayanan Medis. Driver Ambulance Wajib Memastikan Kesiapan Kendaraan, Ketepatan Waktu Penjemputan, Serta Keamanan Pasien Selama Perjalanan Menuju Rumah Sakit.

3. Transportasi Pasien Dalam Kondisi Darurat Dan Non Darurat

Pelayanan Ini Mencakup Pengangkutan Pasien Baik Dalam Kondisi Darurat Maupun Non Darurat. Pada Kondisi Darurat, Driver Ambulance Dituntut Untuk Bergerak Cepat Dengan Tetap Memperhatikan Keselamatan Dan Berkoordinasi Dengan Tim Medis. Sedangkan Pada Kondisi Non Darurat, Pelayanan Dilakukan



Dengan Tetap Menjaga Kenyamanan Dan Keamanan Pasien Sesuai Prosedur Yang Berlaku.

4. Pengantaran Jenazah

Pengantaran Jenazah Adalah Pelayanan Pemindahan Jenazah Dari Rumah Sakit Ke Rumah Duka Atau Tempat Pemakaman. Driver Ambulance Harus Menjaga Kehormatan Dan Etika Dalam Proses Pengantaran, Memastikan Kendaraan Dalam Kondisi Layak, Serta Menjalankan Prosedur Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

5. Dukungan Kegiatan Medis Dan Operasional Rumah Sakit

Driver Ambulance Juga Berperan Dalam Mendukung Kegiatan Medis Dan Operasional Rumah Sakit, Seperti Pengiriman Obat, Alat Kesehatan, Atau Keperluan Lain Yang Mendukung Pelayanan. Selain Itu, Driver Dapat Dilibatkan Dalam Kegiatan Evakuasi, Bencana, Atau Kebutuhan Operasional Lainnya Sesuai Arahkan Manajemen Rumah Sakit.

1.3. Batasan Operasional

Bagian Kendaraan Adalah Unit Pelayanan Di Rumah Sakit Yang Memberikan Pelayanan Transportasi Pasien Dari Rumah Sakit Ke Rumah Sakit Lain Yang Di Tuju, Dari Rumah Pasien Ke Rumah Sakit, Dari Rumah Sakit Ke Rumah Pasien Dan Pelayanan Kegiatan Sosial Kesehatan Masyarakat Dengan Cara Aman Selain Itu Memberikan Pelayanan Bagi Transportasi Jenazah Maupun Kebutuhan Transportasi Rumah Sakit



BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Jenis Tenaga Dan Kemampuan Dari Setiap Staf Yang Ada Di Bagian RS Prima Husada Malang.

NO	Kategori	Pendidikan
1	Kualifikasi	SMA/ Sederajat
2	Pendidikan	SMA/ Sederajat
3	Kompetensi	Memiliki SIM B1 Umum, Sim A Dan Sim C

2.2. Distribusi Ketenagaan

1. Jumlah Driver Disesuaikan Dengan Kebutuhan Layanan Ambulance dan dengan analisis beban kerja
2. Penempatan Driver Pada Shift Pagi, Siang, Middle Dan Malam
3. Tersedia Driver Standby 24 Jam

2.3. Pengaturan Jaga/Dinas

Pengaturan Shift Bertujuan Memastikan Transportasi Tersedia 24 Jam.

Jadwal Dinas	Waktu
Dinas Pagi	Pukul 07.00 – 14.00
Dinas Middle	Pukul 10.00 – 16.00
Dinas Siang	Pukul 14.00 – 22.00
Dinas Malam	Pukul 22.00 – 07.00

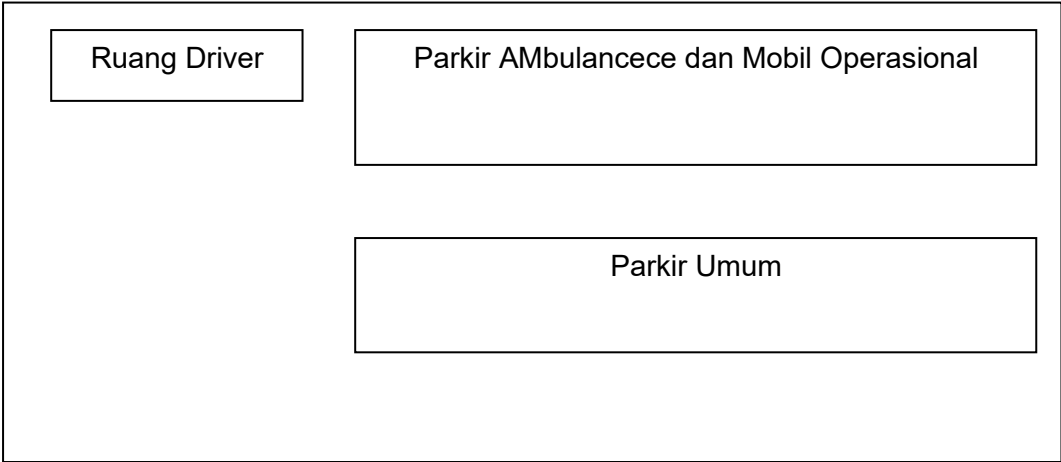


BAB III
STANDAR FASILITAS

3.1. Denah Ruangan

Denah Digunakan Sebagai Acuan Dalam Pos Driver, Parkir Dan Pemeliharaan Ambulance.

Gambar Denah



3.2. Standard Fasilitas

1. Ambulance Transport

Nomor Polisi	: N 8315 EO
Merk / Type	: ISUZU
Jenis Model	: MOBIL PELAYAN KESEHATAN
Pembuatan	: 2022
Tahun Registrasi	: 2023
Isi Silinder	: 2499
Warna	: PUTIH
Nomor Rangka	: MHCPHR54CNJ524425
Mesin	: E524425
Warna TNKB	: PUTIH
Bahan Bakar	: SOLAR
No BPKB	: T06013125

2. Ambulance Transport

Nomor Polisi	: N1833FZ
Merk / Type	: SUZUKI
Jenis Model	: MOBIL PENUMPANG MINIBUS
Pembuatan	: 2024
Tahun Registrasi	: 2024
Isi Silinder	: 1493



Warna : PUTIH METALIK
Nomor Rangka : MHYGDM42VRJ400844
Mesin : G15AID449941

Warna TNKB : PUTIH
Bahan Bakar : BENSIN
No BPKB : V02599060

3. Ambulance Transport

Nomor Polisi : N 888 ABC
Merk / Type : WULING / 350V E2C 4X2 AT
Jenis Model : MOBIL PENUMPANG MINIBUS LISTRIK
Pembuatan : 2025
Tahun Registrasi : 2026
Isi Silinder : 75
Warna : PUTIH
Nomor Rangka : MK3AABE35SJ000170
Mesin : TZ180XS375WCS8071104
Warna TNKB : PUTIH
Bahan Bakar : LISTRIK
No BPKB : WO6313167



BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

Driver Ambulance harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan sikap profesional dalam mendukung pelayanan transportasi pasien yang aman, cepat, dan sesuai standar keselamatan. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh Driver Ambulance meliputi:

1. Mengemudikan Kendaraan dengan Aman dan Cepat

Driver Ambulance wajib mampu mengoperasikan kendaraan Ambulance secara aman, terampil, dan sesuai peraturan lalu lintas yang berlaku. Dalam kondisi kegawatdaruratan, Driver harus dapat menentukan rute tercepat dan paling aman untuk mencapai tujuan tanpa mengabaikan keselamatan pasien, petugas medis, maupun pengguna jalan lainnya.

2. Memahami Prioritas Kondisi Pasien

Driver Ambulance harus memahami tingkat kegawatan pasien yang sedang ditransportasikan sehingga dapat menyesuaikan cara berkendara dengan kondisi pasien. Pemahaman ini penting untuk mendukung kebutuhan medis pasien selama perjalanan dan membantu mempercepat proses rujukan atau evakuasi apabila diperlukan.

3. Menjaga Stabilitas Perjalanan Pasien

Driver Ambulance harus mampu menjaga kenyamanan dan stabilitas pasien selama perjalanan dengan menghindari manuver yang berlebihan, pengereman mendadak, akselerasi yang tidak diperlukan, serta kondisi berkendara yang dapat memperburuk kondisi pasien. Keselamatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama selama transportasi.

4. Berkoordinasi dengan Tenaga Medis

Driver Ambulance wajib menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan dokter, perawat, atau petugas medis yang mendampingi pasien. Koordinasi dilakukan terkait kondisi pasien, kebutuhan perjalanan, pemilihan rute, titik penjemputan maupun tujuan, serta tindakan yang perlu dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi pasien selama perjalanan.

5. Menangani Situasi Darurat di Jalan

Driver Ambulance harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat di jalan, seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas, gangguan kendaraan, kondisi cuaca buruk, maupun hambatan lainnya. Driver juga harus memahami prosedur keselamatan dan tindakan awal yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien, petugas, dan kendaraan Ambulance.

6. Mematuhi Standar Keselamatan dan Operasional Ambulance



Driver Ambulance wajib mematuhi seluruh kebijakan rumah sakit, standar operasional prosedur (SOP), serta ketentuan keselamatan transportasi pasien. Selain itu, Driver

bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum dan sesudah digunakan untuk memastikan Ambulance selalu dalam kondisi siap operasional.

7. Menjaga Profesionalisme dan Kerahasiaan Pasien

Driver Ambulance harus bersikap profesional, sopan, disiplin, dan menjaga kerahasiaan informasi pasien sesuai ketentuan yang berlaku. Selama menjalankan tugas, Driver wajib memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan pasien.



BAB V TATA LAKSANA

5.1 Tata Laksana Transportasi Pasien

5.1.1 Sistem Transportasi Pengantaran Pasien Pulang

A. Petugas Penanggung Jawab

1. Perawat
2. Supir

B. Perangkat Kerja

1. Ambulance Transport
2. Peralatan Medis Obat-Obatan

C. Tata Laksana Transportasi Mengantar Pasien Pulang

1. Perawat menyiapkan pasien dan menentukan kebutuhan alat maupun obat jika diperlukan
2. Perawat memastikan pasien yang akan pulang menggunakan AMbulance rs prima husada malang telah menyelesaikan administrasi
3. Perawat menghubungi supir AMbulance untuk menyiapkan AMbulance
4. Perawat menyiapkan peralatan medis yang diperlukan sesuai kebutuhan
5. Perawat mendampingi pasien sesuai dengan kebutuhan kriteria pasien pulang
6. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur

5.1.2 Sistem Transportasi Rujukan

A. Petugas Penanggung Jawab

1. Dokter
2. Perawat Dan Tim Ambulance
3. Supir

B. Perangkat Kerja

1. Ambulance
2. Peralatan Medis Dan Obat-Obatan
3. Dokumen Rujukan

C. Tata Laksana Sistem Rujukan

1) Alih Rawat

1. Dokter Atau Perawat Menghubungi Rumah Sakit Rujukan
2. Dokter Atau Perawat Memberikan Informasi Pada Rumah Sakit Rujukan Mengenai Kondisi Pasien.
3. Dokter Atau Perawat Memastikan Ketersediaan Tempat Di Rumah Sakit Rujukan,
4. Jika Rumah Sakit Rujukan Telah Tersedia Tempat, Maka Perawat Menghubungi Tim AMbulance Untuk Menyiapkan AMbulance Sesuai Kondisi Pasien.
5. Perawat Menyiapkan Dokumen Rujukan Dan Peralatan Medis Sesuai Kebutuhan



6. Perawat Menghubungi Bagian Farmasi Untuk Menyiapkan Obat-Obatan Yang Diperlukan Selama Transfer Pasien
7. Pasien Telah Menyelesaikan Administrasi
8. Dokter Atau Perawat Memastikan Kondisi Pasien Stabil Sebelum Transfer
9. Dokter Dan Atau Perawat Mendampingi Pasien Sesuai Dengan Kriteria Kondisi Pasien
10. Petugas Melakukan Proses Rujukan

2) Pemeriksaan Diagnostik

1. Pasien / Keluarga Pasien Dijelaskan Oleh Dokter Jaga mengenai tujuan Pemeriksaan Diagnostik, Bila Setuju Maka Keluarga Pasien Harus Mengisi Informed Consent
2. Perawat Menghubungi Rumah Sakit Rujukan
3. Perawat Menghubungi Petugas Ambulance

5.1.3. Sistem Transportasi Home Care

A. Petugas Penanggung Jawab

1. Dokter Umum
2. Perawat Home Care
3. Supir

1. B. Perangkat Kerja

1. Ambulance
2. Peralatan Medis Dan Obat-Obatan

C. Tata Laksana Penjemputan Pasien Home Care

1. Pasien Home Care Menghubungi Petugas Home Care Di Jam Kerja Pagi
2. Petugas Home Care Menghubungi Petugas Ambulance Untuk Mengadakan Penjemputan Ke Rumah Pasien
3. Perawat Home Care Mempersiapkan Peralatan Medis Sesuai Kebutuhan Pasien
4. Perawat Home Care Menghubungi Farmasi Untuk Menyiapkan Kebutuhan Obat Yang Diperlukan
5. Dokter Dan Atau Perawat Home Care Melakukan Penjemputan
6. Pasien Menyelesaikan Administrasi

5.1.4 Sistem Transportasi Ambulance On Call

A. Petugas Penanggung Jawab

1. Dokter IGD
2. Perawat IGD

B. Perangkat Kerja

1. Ambulance
2. Peralatan Medis Dan Obat-Obatan

C. Tata Laksana Penjemputan Pasien

1. Pemesan Menghubungi Bagian Triase
2. Petugas Triase Harus Menanyakan Secara Jelas Informasi



Mengenai :

1. Nama Pasien
2. Nama Pemesan
3. Keadaan/ Keluhan Pasien
4. No Yang Bisa Dihubung
5. Alamat Pasien
6. Apakah Rumah Pasien Bisa Dilalui Ambulance
7. Petugas Triase Menghubungi Bagian AMBulance Untuk Menyiapkan AMBulance
8. Petugas Triase Menyiapkan Peralatan Medis Sesuai Kebutuhan
9. Petugas Triase Menghubungi Bagian Farmasi Untuk Menyiapkan Obat-Obatan Yang Diperlukan Selama Proses Penjemputan
10. Petugas Melakukan Penjemputan

5.1.5 Sistem Transportasi Pengantaran Jenazah

A. Petugas Penanggung Jawab

Supir

B. Perangkat Kerja

Mobil Jenazah

C. Tata Laksana Transportasi Jenazah

1. Petugas Kamar Jenazah Menghubungi Petugas Mobil Jenazah Untuk Pengantaran Jenazah
2. Petugas Menyiapkan Mobil Jenazah
3. Keluarga Menyelesaikan Administrasi
4. Petugas Melakukan Pengantaran Jenazah

5.2 Tata Laksana Pembersihan Armada

1. Pembersihan

Pembersihan Armada Dilakukan Oleh Petugas Ambulance, Untuk Memastikan Ambulance Selalu Dalam Kondisi Bersih Dan Siap Pakai

2. Disinfeksi

- a) Disinfeksi Dilakukan Oleh Petugas AMBulance Jika Armada Terkena Tumpahan Cairan Tubuh Atau Darah, Atau Setelah Digunakan Untuk Mengangkut Pasien Menular Atau pun Airbone Desiase
- b) Disinfeksi Dilakukan Dengan Menggunakan Cairan Clorin 0.5 % Jika Terkena Tumpahan Cairan Tubuh Atau Darah, Dan Menggunakan Clorin 0.05 % Jika Tidak Ada Tumpahan Cairan Tubuh Atau pun Darah Kemudian Bilas Dengan Air Bersih
- c) Disinfeksi Lanjutan Dengan Drymist, Dilakukan Dengan Cara:

1. Petugas Ambulance Melaporkan Permintaan Disinfeksi Dengan Drymist Ke Bagian Sanitasi
2. Petugas PPI Melakukan Validasi Armada Yang Akan Di Lakukan Drymist
3. Petugas Ambulance Menyiapkan Armada Yang Akan Dilakukan Disinfeksi Drymist Yang Sebelumnya Telah Dilakukan Pembersihan Permukaan
4. Petugas Sanitasi Melakukan Disinfeksi



5. Setelah Dilakukan Disinfeksi Biarkan Armada Tertutup Selama 1 Jam Sebelum Digunakan

BAB VI
LOGISTIK

Unit	Merk	Pembelian Tahun	STNK (tanggal)	Pembayaran Pajak (sudah/belum)	Asuransi (Ya/Tidak)	Atas Nama
Wuling EV	WULING	2026	5-1-2027	Sudah	Ya	PT DPM
Traga	Isuzu	2022	23-6-2026	Sudah	Tidak	PT DPM
APV	Suzuki	2024	10-2026	Sudah	Tidak	PT DPM

No	Kendaraan	Alat / Nama	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Ambulan WULING (Digunakan)	Tempat tidur pasien	1 buah	Baik	
		Tabung O2 Besar	1 buah	Terisi penuh	Butuh ruangan untuk tempat penyimpanan alat2 dan sperpat ambulan
		Tabung O2 kecil	1 buah	Terisi penuh	
		Handschoon	1 pax	Baik	
		Masker	1pax	Baik	
		Kantong Plastik (Kuning dan Hitam)	1 pak	Baik	Digunakan untuk linen bekas pasien dan sampah yang tertinggal di ambulan (Warna kuning untuk infesius, hitam untuk non infeksius).
		Handscrub	1 botol	Tersisa setengah	
		Wastafel	1 buah	Baik	



No	Kendaraan	Alat / Nama	Jumlah	Kondisi	Keterangan
		Inventer	1 buah	Baik	Untuk pemindah dari DC ke AC
		Selimut	1 buah	Baik	
		Tutup Keranda	1 buah	Baik	
		Keranda	1 buah	Baik	
		Apar	1 buah	Baik	
		Segitiga Pengaman	1 buah	Baik	
		Lampu dalam	1 buah	Menyala	
3	Ambulan Traga (Digunakan)	Tempat tidur pasien	1 buah	Baik	
		Tabung O2 Besar	1 buah	Terisi penuh	
		Tabung O2 kecil	1 buah	Terisi penuh	
		Tisu	1 buah	Terisa setengah	
		Apar	1 buah	Baik	
		Lampu dalam (bulat)	1 buah	Menyala	
		Lampu dalam (panjang)	1 buah	Menyala	
		Tandu	1 buah	Baik	
		Handschoon	1 pax	Baik	
		Kantong Plastik (Kuning dan Hitam)	1 pak	Baik	Digunakan untuk linen bekan pasien dan sampah yang tertinggal di ambulan (Warna kuning untuk infesius, hitam untuk non infeksius).
		Handscrub	1 botol	Tersisa setengah	



No	Kendaraan	Alat / Nama	Jumlah	Kondisi	Keterangan
		Inventer	1 buah	Baik	Untuk pemindah dari DC ke AC
		Selimut	1 buah	Baik	
		Apar	1 buah	Baik	
		Segitiga Pengaman	1 buah	Baik	
4	SIM (Surat Izin Mengemudi)	Edi Nur Slamet	2 buah	Masih berlaku	SIM B1: 5/11/2029 SIM C : 5/11/2027
		Agus Suhartono	2 buah	Masih berlaku	SIM B1: 09/8/2027 SIM C : 09/8/2027
		Guruh Hadi Wardono	2 buah	Masih berlaku	SIM A: 21/3/2028 SIM C: 21/3/2027
		M Arif	2 buah	Masih berlaku	SIM A: 12/1/2026 SIM C: 12/1/2026
		Eriawan	2 buah	Masih berlaku	SIM A : 10/02/2026 SIM C : 10/02/2026
5	STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	Ambulan L 300	1 buah	Masih berlaku	(8 Maret 2026) Sudah dilakukan perpanjangan
		Ambulan Traga	1 buah	Masih berlaku	
		Suzuki APV	1 buah	Masih berlaku	

6.1 Administrasi Dan Pengelolaan

Dalam Menunjang Transportasi Pasien Dari Rumah Sakit Ke Rumah Sakit Lain, Atau Dari Rumah Pasien Ke Rumah Sakit Atau Sebaliknya Dengan Pelayanan Yang Baik Maka Diperlukan Pengelolaan Administrasi Pelayanan Transportasi Yang Baik

6.2. Penyediaan Peralatan Dan Obat-Obatan

Dalam Penyediaan Peralatan Ambulance Di Rumah Sakit Menggunakan Prosedur Yang Diterapkan Di Rumah Sakit, Yaitu Melalui Persetujuan Direktur Dan Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit. Perawatan Peralatan AMbulance Dilakukan Oleh IPSRS



Setiap 1 Minggu Sekali Atau Sesuai Kebutuhan, Sedangkan Untuk Kebutuhan Obat-Obatan Dan Alat Habis Pakai Ambulance Disediakan Oleh Farmasi Rumah Sakit.

6.3. Pemeliharaan Dan Penyediaan Bahan Bakar

1. Pemeliharaan Kendaraan

Pemeliharaan Kendaraan Dimaksudkan Untuk Menjaga Kondisi Kendaraan Baik Ambulance Maupun Ambulance Jenasah / Mobil Jenasah Rumah Sakit Dalam Keadaan Laik Jalan Dan Siap Setiap Saat Dibutuhkan, Maka Dari Itu Diperlukan Perawatan Mobil Rutin Yang Meliputi

- Pemeriksaan Kondisi Fisik Ambulance Melalui Pengecekan Kesiapan Kendaraan Dan Kebersihan Setiap Kendaraan Ambulance
- Ganti Oli Sesuai Dengan Pemakaian Kendaraan
- Servis Peralatan Kendaraan Baik Servis Rutin Maupun Servis Yang Dikarenakan Kerusakan Kendaraan

2. Penyediaan Bahan Bakar

Pemeliharaan Kendaraan Meliputi Juga Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Yang Dilakukan Pengisian Di Tempat SPBU Yang Ditunjuk Oleh Rumah Sakit Maupun SPBU Lainnya.

3. Tata Cara Mengisian Bahan Bakar

1. Petugas Kendaraan Selalu Mengecek Pemakaian Kendaraan Termasuk Bahan Bakar Kendaraan, Jika Indikator BBM Kendaraan Sudah Mencapai Setengah Indikator, Maka Driver Ambulance Wajib Mengisikan Bahan Bakar Kendaraan Ke SPBU
2. Petugas Driver Ambulance Minta Nota untuk ditukarkan dengan kas kecil (reimburse)
3. Menandatangani Penyerahan Uang dan nota di Bagian Keuangan

4. Tata Cara Mengisian Bahan Listrik

Petugas Kendaraan Selalu Mengecek Pemakaian Kendaraan Termasuk Energi Listrik Kendaraan, Jika Indikator Kendaraan Sudah Mencapai Setengah Indikator, Maka Driver Ambulance Wajib Mengisikan pada portal listrik yang telah disediakan



BAB VII KESELAMATAN PASIEN

7.1 Ruang Lingkup

Keselamatan Pasien (Patient Safety) Adalah Suatu Sistem Dimana Rumah Sakit Membuat Asuhan Pasien Lebih Aman. Sistem Keselamatan Pasien Memiliki 6 Sasaran, Yaitu Ketepatan Identifikasi Pasien (Nama, Tanggal Lahir), Peningkatan Komunikasi Efektif (S-BAR), Peningkatan Obat Yang Perlu Diwaspadai, Kepastian Tepat Lokasi Prosedur Dan Tepat Pasien Operasi, Pengurangan Resiko Infeksi, Pengurangan Resiko Pasien Jatuh (Lihat Gelang Warna Kuning Pada Pasien), Adapun Yang Terdapat Di Bagian Kendaraan Meliputi :

1. Ketepatan Identifikasi Pasien (Nama, Tanggal Lahir, Alamat)
2. Peningkatan Komunikasi Efektif (SBAR)
3. Pengendalian Infeksi
4. Mengurangi Resiko Pasien Jatuh

7.2 Tujuan

Keselamatan Pasien Ini Bertujuan Antara Lain

1. Sebagai Unsur-Unsur Penunjang Yang Mendukung Terciptanya Suasana Kerja Yang Aman, Baik Berupa Materil Maupun Non Material
2. Terciptanya Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit
3. Meningkatnya Akuntabilitas Rumah Sakit Terhadap Pasien Dan Masyarakat
4. Menurunkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Di Rumah Sakit

7.3 Standar Keselamatan Pasien

1. Hak Pasien
2. Mendidik Pasien Dan Keluarga
3. Keselamatan Pasien Dan Kesiambungan Pelayanan
4. Penggunaan Metoda-Metoda Peningkatan Kinerja Untuk Melakukan Evaluasi Dan Program Peningkatan Keselamatan Pasien
5. Mendidik Staf Tentang Keselamatan Pasien
6. Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien
7. Komunikasi Merupakan Kunci Bagi Staf Untuk Mencapai Keselamatan Pasien

7.4 Pelaksanaan

1. Sistem Keselamatan Pasien

A. Ketepatan Identifikasi Pasien

Pasien Yang Akan Menggunakan Ambulance Atau pun Ambulance Jenasah Diidentifikasi Terlebih Dahulu Menggunakan Identitas Pasien Yang Meliputi :
Nama, Tanggal Lahir



B. Peningkatan Komunikasi Efektif (SBAR)

1. Petugas Dari Ruang Perawatan / Unit Gawat Darurat Menginformasikan Permintaan Penggunaan Ambulance Kepada Petugas Ambulance Melalui Telepon Secara Jelas
2. Petugas Ambulance Mencatat Permintaan Ambulance Pada Buku Pesanan Dan Mengklarifikasi Kembali Kepada Bagian Yang Akan menggunakan Ambulance Pada Saat Siap Pengantaran Atau Penjemputan
3. Petugas Kasir Bangsal / Ruang Perawatan Memberikan Formulir Permintaan Ambulance Kepada Keluarga Pasien Yang Digunakan Untuk Pembayaran Administrasi Ambulance Dan Diberikan Kepada Petugas Ambulance Untuk Pelayanan Penggunaan Ambulance Sesuai Tempat Yang Akan Dituju
4. Petugas Ambulance Bersama Perawat Menyiapkan Peralatan Yang Akan Digunakan Untuk Pengantaran Atau Penjemputan Pasien

7.5 Pengendalian Infeksi

1. Cuci Tangan Sebelum Dan Sesudah Bekerja Untuk Mencegah Infeksi Silang
2. Pemakaian Alat Pelindung Diri Untuk Mencegah Kontak Dengan Darah Dan Cairan Infeksi Yang Lain Seperti Masker, Sarung Tangan, Googles Dan Apron Jika Dibutuhkan
3. Pengelolaan Jarum Dan Alat Tajam Lain Untuk Mencegah Perlukaan
4. Pembersihan Ambulance Setiap Penggunaan Pengantaran Atau Penjemputan Pasien
5. Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Dan Sanitasi Ruangan

7.6 Mengurangi Resiko Pasien / Jenasah Jatuh

1. Rumah Sakit Menyediakan Peralatan Kesehatan Yang Dapat Mengurangi Resiko Pasien / Jenasah Jatuh Pada Saat Pemindahan Pasien / Jenasah Ke Dalam Ambulance Atau Mobil Jenasah, Pada Proses Transfer Maupun Pemindahan Pasien/Jenasah Dari Ambulance Atau Mobil Jenasah.
2. Fasilitas Ambulance Dan Mobil Jenasah Yang Sudah Dilengkapi Dengan Tempat Untuk Meletakkan Brankar Yang Disebut Dengan Landasan. Landasan Brankar Berfungsi Untuk Mempermudah Brankar Masuk Dan Keluar.
3. Brankar Dilengkapi Dengan Sabuk Pengaman. Cara Pemindahan Pasien / Jenasah Ke Dalam Maupun Keluar Ambulance / Mobil Jenasah yang Tepat Dan Menghindari Resiko Pasien/ Jenasah Jatuh.



4. Dalam Penjemputan Pasien Atau Pengantaran Pasien Terdapat Dokter Dan Atau Pun Perawat Sesuai Dengan Keadaan Pasien



BAB VIII KESELAMATAN KERJA

Keselamatan Kerja Bertujuan Melindungi Petugas Dari Risiko Kerja Melalui:

8.1 Pelatihan Rutin

Pelatihan rutin dilakukan untuk memastikan driver Ambulance memiliki kompetensi dalam mengemudi aman (defensive driving), memahami rute tercepat, serta mampu menghadapi kondisi darurat di jalan. Pelatihan juga mencakup penanganan dasar kegawatdaruratan, komunikasi dengan tim medis, serta pemahaman prosedur operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan cepat, tepat, dan aman. Pelatihan rutin ini juga dilakukan pada diklat internal rumah sakit.

8.2. Penggunaan Alat Pelindung

Driver Ambulance wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan, seperti sabuk pengaman, sepatu tertutup, sarung tangan (jika diperlukan), dan perlengkapan lain yang mendukung keselamatan kerja. Penggunaan APD ini bertujuan untuk mengurangi risiko cedera saat berkendara, evakuasi pasien, maupun saat berada di lokasi kejadian yang berpotensi berbahaya.

8.3. Prosedur Tanggap Darurat

Driver Ambulance harus memahami dan menjalankan prosedur tanggap darurat secara tepat, termasuk penggunaan sirine dan lampu prioritas sesuai aturan, koordinasi dengan tim medis dan fasilitas kesehatan tujuan, serta tindakan cepat saat terjadi kendala di perjalanan (misalnya kemacetan, kecelakaan, atau kerusakan kendaraan). Prosedur ini penting untuk menjamin keselamatan pasien, petugas, dan pengguna jalan lainnya.



BAB IX PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian Mutu Dilakukan Melalui:

9.1. Evaluasi Berkala

Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai kinerja driver Ambulance secara rutin, baik dari aspek keselamatan berkendara, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap SOP, maupun kondisi kendaraan. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh atasan langsung melalui supervisi lapangan, review checklist harian, serta penilaian disiplin kerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja.

9.2. Audit Internal

Audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan secara sistematis terhadap pelaksanaan tugas driver Ambulance, meliputi kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap prosedur, kondisi kendaraan, serta penggunaan alat keselamatan. Audit dilakukan secara berkala oleh tim yang ditunjuk untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

9.3. Pelaporan Insiden

Setiap kejadian yang tidak diharapkan, seperti kecelakaan, hampir celaka (near miss), kerusakan kendaraan, atau keterlambatan pelayanan, wajib dilaporkan oleh driver secara tepat waktu dan jujur. Pelaporan ini bertujuan untuk dilakukan analisis penyebab sehingga dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang serta meningkatkan keselamatan kerja.

9.4. Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, audit, dan laporan insiden. Bentuk perbaikan dapat berupa pembaruan SOP, peningkatan pelatihan, perbaikan sistem kerja, maupun pemeliharaan kendaraan. Upaya ini dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan, dan kinerja tim driver Ambulance



BAB X PENUTUP

Demikian Pedoman Pelayanan Di Unit Driver Ambulance Dibuat Dengan
Harapan Meningkatkan Pelayanan Dibidang Transportasi Di Rumah Sakit
Prima Husada Malang.

Ditetapkan Di Malang
Pada Tanggal 18 April 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini.,M.Kes